

F

誤嚥性肺炎

aspiration pneumonia

到達目標

- 誤嚥性肺炎の背景，病態が理解できる
- 嚥下障害を理解できる
- 誤嚥性肺炎の抗菌薬戦略を説明できる
- 誤嚥性肺炎の口腔ケアと予防策を実施できる

病因・病態・疫学

『成人肺炎診療ガイドライン 2024』では，高齢者肺炎への対応を充実させるために新たに「誤嚥性肺炎」の項目が設けられた。「誤嚥のリスクがある宿主に生じる肺炎」を誤嚥性肺炎と呼ぶ。したがって，市中肺炎にも，医療・介護関連肺炎にも，院内肺炎にも誤嚥性肺炎は含まれる。そこで，嚥下障害を生ずる病態が重要になる（表 1）。ただし，誤嚥と誤嚥性肺炎は同一ではない。たとえば，誤嚥したものを十分に咯出できる能力がある場合は，肺炎には至らないことが推測される。そのため，誤嚥のリスクとともに，咯出能や気道クリアランスの低下，免疫能の低下などは肺炎発症のリスクであるといえる。これらの原因の多くは，加齢などに伴う全身の衰弱が関連する。すなわち，誤嚥性肺炎の多くは加齢に関連した全身の機能低下，および，それに伴う嚥下機能障害によって生じている（表 1）¹⁾。

日本の死因では肺炎や誤嚥性肺炎が上位であるが，

その要因は人口の高齢化による高齢者肺炎の増加とこれによる死亡者の増加であり，この高齢者肺炎の大半を誤嚥性肺炎が占める²⁾。入院する市中肺炎症例の半分以上，また院内肺炎の多くが誤嚥性肺炎と考えられる³⁾。

診断・検査

誤嚥性肺炎の定義に基づき，「誤嚥のリスクを有する宿主（表 1）における肺炎」を誤嚥性肺炎と診断する。誤嚥性肺炎の多くは不顕性誤嚥によって発症するため，診断が困難であることも少なくない。嚥下機能の評価方法にはベッドサイドでできるものから，嚥下造影まで種々のものがある（表 2）。神経筋疾患などで介護度の高い高齢患者では，座位で嚥下造影を行うと検査中および検査後に誤嚥する危険性があり，ベッドサイドで行える嚥下機能評価や簡易嚥下誘発試験のような検査を優先し，病状を把握しながら検査を追加する。

治療

肺炎発症に至った患者背景のアセスメントを行い，治療やケアを決定する。「反復する誤嚥性肺炎」や「疾患末期や老衰」と判断される場合には，アドバンス・ケア・プランニング，すなわち合意に基づいた症状緩和を基本とする医療・ケアを考慮する¹⁾。

表 1 誤嚥のリスク

誤嚥のリスク	
原因	病態
・ 嚥下機能低下	嚥下障害，意識障害，咳嗽反射障害 ・ 意識障害 ・ 全身衰弱，長期臥床 ・ 脳血管疾患 ・ 慢性神経疾患（てんかん，慢性神経疾患（てんかん，多発性硬化症，パーキンソン症候群，認知症など） ・ 医原性（気管切開チューブ留置・抜管，経腸栄養，頭頸部手術，薬剤（鎮静薬，睡眠薬，口腔乾燥をきたす抗コリン薬など），全身麻酔） ・ 食道疾患（食道機能不全，食道がん，食道狭窄） ・ 慢性閉塞性肺疾患 ・ 心停止 ・ アルコール
・ 胃食道機能不全	・ 胃食道逆流 ・ 食道機能不全，食道狭窄，医原性（経腸栄養，胃切除など）

誤嚥による肺炎のリスク

原因	病態
咯出能および気道クリアランスの低下	全身衰弱，長期臥床，慢性気道炎症性疾患
免疫能低下	全身衰弱，長期臥床，低栄養，急性脳血管障害

〔日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン 2024 作成委員会（編）：誤嚥性肺炎，成人肺炎診療ガイドライン 2024，メディカルレビュー社，2024，Mandell LA, et al : N Engl J Med 380 : 651, 2019 より作成〕